جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : نجاه محمود دياب ابوطالب
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العمرانيه **العنوان :** --
رقم البطاقة : 26710142102469 **رقم التليفون :** 01123564566 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 14-10-1967 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجاه محمود دياب ابوطالب
National ID: 26710142102469

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذة / نجاه محمود دياب ابوطالب	Request No.	: 13005270
Patient No.	: 26710142102469	Request Date	: 02/05/2024
Path No.	: 1437/24	Verification Date	: 13/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مباشره
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer post NACT .

Nature of the specimen:
Right MRM specimen collected at 2/5/2024.

Gross Examination:
Right MRM measured 30x21x6 cm with covering skin ellipse measured 20x9 cm .
- Tumor extent :A retroareolar greyish white rubbery to firm mass.
- Size: 4.5x4x2.5 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were flattened grossly .
- Distance from margins: 1.5 cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size:14 nodes up to 2x2x1 cm .

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1).

-Acutal tumor cellularity : 50%.
- Ductal carcinoma in situ: Focal (1%).
- Skin involvement: Free nipple and areola.
- Lymph node involvement: (1/14) with extracapsular invasion.
- Resection Margins: Free deep margin .
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response.
- Additional pathologic responce:Lymphocytic rich stroma.

Diagnosis:

Verified by :
dr.esraa magdy

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: نجاه محمود زياد **MR. :** 5695	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient presented for a routine follow-up and was started on aromasin as part of a supportive therapy regimen for a duration of three months, with an annual assessment scheduled for November 2025. The patient was also cleared for a dental consultation regarding the use of Zometa.

The patient was prescribed Zometa in conjunction with aromasin and supportive therapy for a period of three months, with the next clinic visit scheduled for 6/9/2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Reham Ahmed Fathy Ibrahim**

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / نجلاء محمود دياب ابوطالب	Request No.	: 13005270
Patient No.	: 26710142102469	Request Date	: 02/05/2024
Path No.	: 1437/24	Verification Date	: 13/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: ورام دار السلام - مباشره
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Right breast cancer post NACT , MRM specimen :
-Invasive duct carcinoma grade II .
-Acutal tumor cellularity : 50%.
-Free nipple and areola.
-Free deep margin.
- Lymph nodes:Positive (1/14) with extracapsular invasion.
-Pathologic partial response .
-Stage : ypT2 , ypN1.
-RCB : 3.664 , RCB class III.

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Menna Nabil

Verified by :
dr.esraa magdy

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
الادارة الاشعة

Patient Name: Ngah Mahmoud Diab Abou-Taleb	Date : 27/08/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 3238/2023	Pat. ID: 41337

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Bilateral axilllary few subcentimetric lymph nodes.
- Tiny left internal mammary lymph node measuring 6 x 3 mm.
- Few bilateral fissure based and prenchymal pulmonary nodules largest at middle lobe measuring 5 mm.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Small sliding hiatus hernia.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No focal lesions on non contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen on noncontrast basis.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- No definite lytic or sclerotic osseous lesions.

Opinion:

- **Few bilateral tiny pulmonary nodules for follow up.**

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nagal Mahmoud Diab Abou-Taleb	Date : 12/03/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 3238/2023	Pat. ID: 41337

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

Patient is 56years old and is seen for Post NAHT status assessment of a known locally advanced right breast malignant mass

Report:

- Right Breast:
  - A residual ill-defined irregular dense infiltrative process is seen involving the whole left breast measuring 90x55x60mm. It is invading the nipple.
  - Ultrasound shows this mass an irregular hypoechoic mass.
  - Indeterminate level I axillary lymph nodes showing focal cortical thickening.
  - No infra or supraclavicular LNs
- Left Breast:
  - ACR d: homogeneous dense fibro-glandular parenchyma
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - Diffuse foci of microcalcifications.
  - Complementary ultrasound shows small scattered cysts. No solid mass lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post NAHT status of locally advanced right breast malignant infiltrative process showing residual mass with residual indeterminate level I axillary LNs (BIRADS 6)
- Fibrocystic changes of left breast (BIRADS 2)

Best regards,

Dr. Marina Emad

Dr. Amira H Radwan MD,

Breast Imaging consultant,

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name : Ngah Mahmoud Diab Abou-Taleb	Date : 27/08/2023
Exam : C T CHEST	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 3238/2023	Pat. ID: 41337

- Tiny left internal mammary lymph node with few subcentimetric axillary lymph nodes for follow up.
- No evidence of hepatic or osseous metastasis.

Dr. Ali Saber, MSc.

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy
29/08/2023 03:37 م

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]